

Objectif 1 /2 :

1) Les facteurs de risques exogènes des cancers colorectaux sont :

- A. Le tabagisme
- B. L'alimentation riche en graisse et en viande
- C. La consommation d'aspirine
- D. L'alimentation riche en fibres végétales
- E. La sédentarité

2) Le cancer colorectal est :

- A. Une tumeur maligne du tube digestif allant de la valvule iléo-caecale jusqu'au canal anal
- B. Le deuxième cancer digestif en termes de fréquence
- C. Le plus souvent un adénocarcinomes lieberkühniens
- D. Une tumeur de mauvais pronostic
- E. Une tumeur maligne qui se développe sur un état précancéreux

3) Les facteurs de risques endogènes des cancers colorectaux sont :

- A. La rectocolite ulcéro-hémorragique
- B. La diverticulose colique
- C. La maladie de Crohn
- D. L'angiodysplasie colo rectale
- E. Le diverticule de Meckel

4) Parmi ces facteurs endogènes, lequel est le plus incriminé dans la survenue de CCR? :

- A. PAF
- B. Polype adénomateux sporadique
- C. RCH
- D. HNPCC
- E. Syndrome de Gardner

5) Le polype adénomateux colorectal est associé à un risque de dégénérescence plus élevé :

- A. Lorsqu'il est ancien
- B. Lorsqu'il est de type tubuleux
- C. Lorsqu'il est sessile
- D. Lorsqu'il est de siège rectal
- E. Lorsqu'il est de taille > 1 cm

6) Le risque de dégénérescence de RCH augmente avec :

- A. L'âge avancé lors du diagnostic de RCH
- B. L'association à une CSP
- C. L'étendue de la RCH
- D. L'association à une fistule anale chronique
- E. L'association à une dysplasie

7) La Polypose Recto-colique Familiale (PAF) :

- A. Est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive
- B. Est une maladie secondaire à une mutation du gène APC situé sur le chromosome 5
- C. Est responsable de 1% des cancers colorectaux
- D. Est associée à un risque de dégénérescence évalué à 700/0 après 10 ans d'évolution
- E. Est définie par une muqueuse colorectale tapissée de polypes

8) La Polypose Recto-colique Familiale (PAF) Floride :

- A. Est une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante
- B. Est secondaire à une mutation du gène APC situé sur le chromosome 1
- C. Est associée à un risqué de dégénérescence de 100% à l'âge de 40 ans
- D. Est associée un à risque de CCR multifocal
- E. Est définie par une muqueuse colorectale tapissée de polypes

9) Le syndrome de cancer colique familial sans polypose (HNPCC) :

- A. Est à transmission autosomique dominante avec faible pénétrance
- B. Est responsable de 15 % des cancers colorectaux
- C. Est secondaire à une mutation du gène MMR
- D. Peut associer des cancers gynécologiques (ovaire et utérus)
- E. Peut associer des cancers de l'appareil urinaire

10) Le risque de survenu de cancer CCR est élevé en cas de :

- A. ATCD personnel de CCR
- B. La polypose adénomateuse
- C. Un apparenté au 1^{er} degré ayant un adénome à l'âge de 65 ans
- D. Maladie inflammatoire de l'intestin
- E. Syndrome de Lynch

11) Le risque de survenu de cancer CCR est très élevé en cas de :

- A. ATCD personnel de CCR
- B. La polypose adénomateuse
- C. Un apparenté au 1^{er} degré ayant un adénome à l'âge de 65 ans
- D. Maladie inflammatoire de l'intestin
- E. Syndrome de Lynch

Objectif 3 :

12) L'angle colique gauche :

- A. Fait partie du colon transverse
- B. Est en rapport avec le pôle inférieur de la rate
- C. Répond en arrière au corp du pancréas
- D. Répond en arrière au pôle supérieur du rein gauche
- E. Vient au contact de la 2^{ème} portion du duodénum et la face postérieure de l'estomac

13) Le colon transverse :

- A. Répond en avant à la vésicule biliaire
- B. Est en rapport avec le duodénum et avec la tête du pancréas
- C. Répond à l'angle duodéno-jéjunal à droite
- D. Est un segment fixe du colon
- E. Est de calibre moins important que le colon gauche

14) La vascularisation artérielle colique :

- A. Est tributaire de l'artère mésentérique supérieure à gauche
- B. Est tributaire de l'artère iliaque gauche pour le colon sigmoïde
- C. Est anastomotique entre 2 systèmes par l'arcade de Riolan
- D. Vascularise aussi l'intestin grêle par l'intermédiaire de l'artère mésentérique supérieure
- E. Est de type terminale

15) L'artère mésentérique supérieure :

- A. Vascularise l'intestin grêle
- B. Vascularise le colon droit
- C. Naît de la face antérieure de l'aorte abdominale, en regard de la deuxième vertèbre lombaire (L2)
- D. Participe à la vascularisation du bloc duodéno-pancréatique
- E. Chemine en avant du pancréas

16) La veine mésentérique supérieure :

- A. Naît de la confluence des veines rectales supérieures, des veines sigmoïdiennes et de la veine colique gauche
- B. Fusionne avec la veine splénique pour former le tronc spléno-mésaraïque
- C. Naît dans le mésentère, près de la valvule iléo-caecale
- D. Chemine à droite de l'artère mésentérique supérieure
- E. Se jette dans le tronc porte

17) Le tronc gastro-colique de Henlé correspond à la réunion des veines :

- A. Gastro-épiploïque droite
- B. Pancréatico-duodénale postérieure
- C. Colique supérieure droite
- D. Colique moyenne
- E. Rénale droite

18) Le drainage lymphatique du colon :

- A. Est anarchique, mal systématisé
- B. Se répartit en 5 groupes
- C. Explique le fait que les cancers du côlon gauche donnent plutôt des métastases du foie gauche
- D. Est la voie empruntée par les métastases hépatiques
- E. Suit les pédicules artério-veineux dans les mésentères

19) Le rectum :

- A. Peut être divisé en 4 parties sur le plan chirurgical
- B. Est le segment terminale du tube digestif
- C. À la forme d'un réservoir cylindrique de 15 cm de long
- D. Fait suite au côlon sigmoïde au niveau de la 2^{ème} vertèbre sacrée
- E. Comporte deux parties : le rectum pelvien, ou ampoule rectale et le rectum périnéal ou canal anal

20) Le rectum :

- A. Traverse le petit bassin de haut en bas dans sa moitié postérieure
- B. Est entouré d'une séreuse sur toute sa hauteur
- C. Est divisé en deux parties par le péritoine
- D. Est enveloppé, surtout sur sa face antérieure, d'un tissu cellulo-gras appelé mésorectum
- E. Sous-péritonéal est entouré par un feuillet viscéral ou Fascia Recti

21) Un cancer de la paroi antérieure du rectum risque d'envahir :

- A. L'aponévrose de Denonvilliers
- B. L'aponévrose de Waldeyer
- C. Le vagin
- D. Les vésicules séminales
- E. Le sacrum

22) Le rectum :

- A. En postérieur répond au sacrum par l'intermédiaire de l'aponévrose pré-sacrée
- B. En antérieur, chez l'homme, répond à l'aponévrose prostatopéritonéale de Denonvilliers
- C. Dans sa partie sus-péritonéale, répond à l'urètre
- D. En antérieur, chez la femme, répond à la face postérieure de la vessie
- E. Dans sa partie sus-péritonéale, peut être en rapport avec l'appendice

23) La vascularisation artérielle du rectum est assurée par :

- A. L'artère rectale supérieure
- B. Les artères rectales moyennes
- C. Les artères rectales inférieures
- D. Le tronc des artères sigmoïdiennes
- E. L'artère vaginale postérieure

24) À propos le drainage lymphatique, le rectum est drainé par :

- A. Les hémorroïdaux supérieurs
- B. Les ganglions du mésorectum
- C. Le ganglion de Mondor
- D. Les ganglions inguinaux profonds
- E. Les ganglions rétro-sacrés

25) Les cancers colo-rectaux en macroscopie sont :

- A. D'aspect qui varie selon le siège de la tumeur
- B. Ulcérées et en virole dans les segments du colon droit
- C. Le plus souvent d'une forme ulcéro-infiltrante
- D. Bourgeonnantes et peu ulcérées au niveau du côlon gauche
- E. Saignantes et fragiles

26) L'extension locorégionale des CCR :

- A. Se fait en profondeur formant une tumeur sténosante
- B. Se fait dans 3 sens
- C. Se fait en latéral surtout pour le colon sigmoïde
- D. Se fait en profondeur et c'est à la base des classifications histo-pronostiques
- E. En longitudinal, permet de définir la clairance latérale

27) Une tumeur du côlon est classée T3 lorsqu'elle envahit :

- A. La sous-séreuse
- B. La séreuse
- C. Le Mésocolon
- D. Un organe de voisinage
- E. Une frange épiploïque

28) Un adénocarcinome bien différencié qui envahit la musculuse avec aucun ganglion envahi et absence de métastases à distance.

La tumeur est classée :

- A. pTis N0 M0
- B. pT1 N0 M0
- C. pT2 N0 M0
- D. pT3 N0 M0
- E. pT4 N0 M0

Objectif 4 + 5 :

29) Les circonstances de découverte des cancers colique sont :

- A. Les ténesmes
- B. Les épreintes
- C. La fièvre au long cours
- D. Les troubles dyspeptiques
- E. Le syndrome de Koenig

30) Les circonstances de découverte du cancer rectal sont :

- A. Les faux besoins
- B. Les mélénas
- C. Les épreintes
- D. Les ténesmes
- E. Splénomégalie

31) Un CCR peut-être découvert à l'occasion de :

- A. Une altération de l'état général
- B. Une douleur de type solaire
- C. Une fécalurie
- D. Des coliques hépatique
- E. Un syndrome occlusif

32) Le toucher rectal :

- A. Fait partie du bilan d'extension du cancer du rectum
- B. Apprécie la résécabilité d'un cancer du rectum
- C. Permet d'évoquer le diagnostic du cancer du rectum dans près de 100% des cas
- D. Permet d'apprécier le siège de la tumeur rectale par rapport au plan des releveurs
- E. Fait partie du bilan d'extension du cancer du colon

33) Devant une tumeur du haut rectum sténosant, la colonoscopie :

- A. Doit être couplée à une coloration à l'indigo-carmin
- B. Doit explorer tout le cadre colique si possible
- C. Est l'examen de référence pour apprécier la distance par rapport à la marge anale
- D. Nécessite une préparation colique rapide et adéquate
- E. Nécessite une anesthésie générale

Objectif 5 :

34) Le bilan d'extension tumorale du cancer du côlon comporte :

- A. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien
- B. Un colo-scanner
- C. Une coloscopie totale
- D. Une vidéoscopie par vidéo-capsule si tumeur colique sténosante
- E. Un toucher rectal

35) Le bilan d'extension d'une grosse tumeur du rectum palpée au TR comporte :

- A. Un examen clinique
- B. Une colonoscopie totale
- C. Une IRM pelvienne
- D. Une écho-endoscopie
- E. Une IRM hépatique

36) Devant un cancer du rectum, l'IRM pelvienne est demandée pour apprécier :

- A. La marge circonférentielle
- B. Le siège exacte de la tumeur
- C. L'atteinte ganglionnaire
- D. L'envahissement des couches de la paroi rectale
- E. L'extension à distance

37) En cas de cancer rectal, L'échographie endorectale (EER) représente l'examen de référence pour :

- A. Préciser le degré d'infiltration du méso rectum
- B. Permettre un bilan d'extension loco-régionale en cas de sténose rectale
- C. Préciser l'extension aux organes de voisinage
- D. Évaluer le degré d'infiltration pariétale d'une petite tumeur
- E. Évaluer l'extension ganglionnaire

Objectif 7 :

38) Les principes généraux du traitement curatif chirurgical des CCR comportent :

- A. Une adaptation au terrain du patient
- B. Une voie coelioscopique qui est recommandée
- C. Une marge de sécurité d'au moins 4 cm de part et d'autre de la tumeur
- D. Une exploration de toute la cavité abdominale après le geste de résection
- E. Un curage ganglionnaire associé

39) Le traitement chirurgical du cancer du côlon droit non compliqué consiste à pratiquer :

- A. L'exérèse de la tumeur avec marge de résection maximale de 5cm de part et d'autre
- B. La résection systématique de la dernière anse iléale
- C. La résection systématique de la moitié droite du côlon transverse
- D. Un curage ganglionnaire nécessitant la ligature section de l'AMS avant la naissance de l'artère colique droite
- E. Une anastomose digestive pour rétablir la continuité digestive

40) L'hémi colectomie gauche vraie pour le traitement chirurgicale du cancer du côlon gauche non compliqué comporte :

- A. Une résection de tout le côlon gauche depuis l'union $\frac{1}{3}$ moyen- $\frac{1}{3}$ gauche du côlon transverse jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne
- B. Une ligature de l'artère mésentérique inférieure à son origine
- C. Une anastomose iléo-rectale pour rétablir la continuité digestive
- D. Une ligature de la VMS au bord supérieur du pancréas
- E. Un curage ganglionnaire aortique

41) À propos les particularités du traitement chirurgical du cancer du côlon transverse non compliqué :

- A. La colectomie transverse est l'intervention de référence
- B. On peut pratiquer une hémi-colectomie droite avec anastomose iléo-transverse
- C. On peut pratiquer une hémi-colectomie gauche avec anastomose colorectale
- D. On peut pratiquer une colectomie totale avec anastomose iléo-rectale
- E. Le curage ganglionnaire n'est pas recommandé pour cette localisation

42) L'indication d'une colectomie totale est portée devant :

- A. Une maladie de Crohn iléo-caecale dégénéré
- B. Une PAF Floride dégénérée
- C. La présence de 2 cancers synchrones du colon droit et gauche
- D. Une perforation diastatique du caecum secondaire à un cancer du côlon gauche
- E. Une perforation d'un cancer colique gauche

43) Le traitement chirurgicale d'un cancer colique en occlusion peut être fait par :

- A. Une colostomie première de décharge
- B. Une hémi colectomie droite avec anastomose iléo-transverse pour les cancers du côlon droit
- C. L'intervention de Bouilly Volkmann pour un cancer de l'angle colique gauche
- D. L'intervention de Hartmann pour un cancer du côlon droit
- E. Une Colectomie totale avec anastomose iléo-rectale pour un cancer de l'angle colique droit avec des lésions ischémiques du cæcum

44) Après exérèse local d'un polype rectal en mono bloc, celle-ci est suffisante si l'examen anatomopathologique conclut à :

- A. Un cancer in situ
- B. Des marges de section positives
- C. Un polype hyperplasique
- D. Un cancer invasif :T2
- E. Un ADK indifférencié

45) La chimiothérapie pour le traitement des cancers coliques :

- A. Est indiquée en adjuvant pour les tumeurs avec atteinte ganglionnaire à l'histologie (N+)
- B. A pour but de réduire le risque de récidence
- C. Est indiquée en adjuvant pour toutes les tumeurs classées T3N0M0
- D. A pour but de prolonger la survie
- E. Est discutée en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) seulement si présence des facteurs de mauvais pronostic

46) Les principes généraux du traitement chirurgicale du cancer du rectum sont :

- A. Des marges distales minimale de résection de 5 cm
- B. L'exérèse totale extra fasciale du mésorectum pour les tumeur du moyen rectum
- C. Le curage ganglionnaire mésentérique inférieur
- D. Le curage ganglionnaire iliaque primitif
- E. La conservation de l'innervation pelvienne

47) Le traitement chirurgical du cancer du haut rectum :

- A. Se fait par voie abdominale
- B. Nécessite une résection du rectum et du mésorectum jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de la lésion
- C. Nécessite la ligature de l'AMS à son origine
- D. Emporte l'appareil sphinctérien
- E. Se fait par une résection antérieure du rectum

48) Le traitement chirurgical du cancer du moyen rectum :

- A. Se fait par une résection antérieure du rectum
- B. Nécessite un rétablissement de continuité digestive par anastomose colorectale basse
- C. Doit emporter la tumeur avec une marge distale de 5 cm
- D. Permet une conservation sphinctérienne anale
- E. Sera protégé par une iléostomie ou une colostomie

49) Le traitement chirurgical du cancer du bas rectum :

- A. Nécessite une exérèse complète du méso rectum
- B. Peut être assuré par une résection antérieure
- C. Peut être assuré par une amputation abdomino-périnéale
- D. Comporte un curage iliaque interne
- E. Comporte une ligature des 2 artères hypogastriques

Objectif 8 :

50) Les facteurs de mauvais pronostic des CCR sont :

- A. Le stade TNM avancé
- B. L'instabilité micro satellitaire « MSI »
- C. Les tumeurs occlusives
- D. Le caractère bien différencié
- E. L'engainement péri-nerveux

51) Le taux de survie relative à 5 ans des CCR est de :

- A. 60% pour les cancers stade I
- B. 50% pour les cancers stade II
- C. 20% pour les cancers stade III
- D. 5% pour les cancers stade IV
- E. 60% quel que soit le stade

Objectif 9 :

52) Les éléments de surveillances postopératoire des CCR sont :

- A. L'examen clinique
- B. L'échographie abdominale
- C. La radio-thorax
- D. Le dosage des CA125
- E. L'endoscopie basse tous les 6 mois

Cas Clinique :

Un homme de **65 ans** consulte pour **rectorragies** évoluant depuis **6 mois**.

L'examen trouve un patient avec état hémodynamique stable, pas de masse abdominale palpable.

L'examen de la marge anale conclut à des hémorroïdes internes prolabées Grade 3, le toucher rectal trouve un doigtier souillé de sang, pas de masse palpable.

1) Que proposez-vous ?

- A. Traitement anti hémorroïdaire
- B. Angioscanner abdominal
- C. Vidéo-Capsule
- D. Rectoscopie**
- E. Lavement Baryté

Une **recto-sigmoïdoscopie** a été faite montre la présence d'une lésion bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact, à **6 cm** de la marge anale.

Les biopsies de cette tumeur a montrés la présence d'un **adénocarcinome bien différencié**.

Après un bilan d'extension par TDM TAP et IRM pelvienne la tumeur a été classée **T3N+M0**

2) Quel traitement envisagez-vous :

- A. Une amputation abdomino-périnéale précédée d'une radio-chimiothérapie
- B. Résection antérieure du rectum précédée d'une radio-chimiothérapie**
- C. Résection chirurgicale de la tumeur par voie endo-anale
- D. Intervention de Hartmann
- E. Radiothérapie exclusive

L'examen anatomopathologique de la pièce opératoire montre la présence d'un adénocarcinome bien différencié classé T3N1M0 avec engainement péri nerveux et embolies vasculaires.

3) Quels sont les éléments de mauvais pronostic chez ce patient :

- A. L'atteinte en profondeur de la paroi colique
- B. L'atteinte ganglionnaire**
- C. L'engainement péri-nerveux**
- D. Le caractère bien différencié de la tumeur
- E. L'aspect végétant ou ulcéreux de la tumeur

4) Quel est votre CAT en post-opératoire ?

- A. Une surveillance : contrôle dans 3 mois
- B. Une hormonothérapie
- C. Une radio-chimiothérapie adjuvante
- D. Une chimiothérapie adjuvante**
- E. Une curie thérapie endo anale adjuvante

5) Votre protocole de surveillance sera composé d' :

- A. Une coloscopie totale**
- B. Un scanner pelvien
- C. Une échographie abdomino-pelvienne
- D. Un scanner TAP**
- E. Un dosage de l'antigène carcino-embryonnaire**